

Спиральная компьютерная томография в диагностике рака желудка

Жолдыбай Ж.Ж., Жакенова Ж.К., Потапов А.В., Ахметова Г.С., Иноземцева Н.И.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Ж.Ж.Жолдыбай, Ж.К.Жакенова, А.В.Потапов,
Г.С.Ахметова, Н.И.Иноземцова

Асқазанның қатерлі ісігінің диагностикасындағы
спиральды томограф

Қазақтың онкология және радиологиялық ғылыми
зерттеу институты, Алматы қаласы

Осы мақалада, қазіргі заманғы жоғары технологиялық
тәсілдердің мүмкіндігі ұсынылады, дәлірек айтқанда
спиральды компьютерлік томографтың асқазанның
қатерлі ісігінің диагностикасындағы рөлі.

Асқазанның қатерлі ісігі - әлемдегі қатерлі ісіктер
арасында, екінші орын алады. Осы кезге дейінгі зерттеу
тәсілдері, көп жағдайда асқазанның қатерлі ісігінің
бастапқы кезеңінде анықтауға мүмкіндік бермейді,
сондықтан клиникалық онкологиядағы маңызды
бағыттардың бірі диагностика тәсіл-дерін жетілдіру.
60-90%-ға дейін асқазанның қатерлі ісігінің жайылма
түрі. Рентгенологиялық зерттеу тәсілі сезімталдығы мен
арнайы мүмкіндігі бойынша, эндоскопиялық зерттеумен
теңбе-тең. Жапондық зерттеушілердің мәліметтері
бойынша рентгенологиялық зерттеудің сезімталдығы
80%, эндо-скопияда 86%-ға дейін, арнайы мүмкіндігінің
арақатынасы 99,5% және 97%.

Асқазанның қатерлі ісігінің жайылма түрінің
бастапқы кезеңіндегі диагнос-тикасы, көп жағдайда
диагностикасында рентгенологиялық зерттеу тәсілі –
жалғыз анықтаушы тәсіл.

Зерттеу мақсаты - Асқазанның қатерлі ісігінің
диагностикасындағы спир-альды томографтың
мүмкіндігін зерттеу.

Асқазанның қатерлі ісігіне шалдыққан 14 науқасқа
компьютерлі-томогра-фиялық зерттеу өткізілді, жас
аралығы 44-тен 72-ке дейін. Компьютерлік томограф,
қосымша рентгенологиялық зерттеумен бірге, ісіктің
ағзаға енуі туралы қосымша ақпарат алып қана қоймай,
көрші ағзаларға тарауы мен құрсақ қуысынан тыс лимфа
бездерінің шоғынуы жайлы мәлімет береді. Екі салалы
компьютерлік томографпен зерттеу жасау барысында,
асқазан қабыр-ғасындағы өзгерістерді 7 мм-ге дейін
анықтап, көрші ағзалар мен құрылым-дарына өсуі,
бауырдың метастазды зақымдануы мен құрсақ қуысы
мен тыс лимфа бездерінің шоғынуы анықталады.
Рентгенологиялық және эндоско-пиялық зерттеумен,
қоса асқазанның қатерлі ісігінің кешенді зерттеудің
алгоритміне қосылды.

Spiral CT in diagnostics of gastric cancer

Kazakh Institute of Oncology & Radiology

In the given work possibilities modern high-quality
methods of research, such as a spiral computer tomography,
in diagnostics of cancer of stomach are shown.

In the world the stomach cancer takes the second place

Спиральная компьютерная томография в диагно- стике рака желудка

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

В данной работе показаны возможности современных
высокоинформативных методов исследования, таких как
спиральная компьютерная томография, в диагностике
рака желудка. В мире рак желудка занимает второе
место среди всех злокачественных новообразований.
Существующие методы исследования в большинстве
случаев не позволяют диагностировать начальные про-
явления рака желудка, поэтому усовершенствование
методов диагностики является одним из важнейших на-
правлений клинической онкологии. До 60-90% составляют
диффузные формы рака желудка. Рентгенологический
метод исследования по чувствительности и специфич-
ности сопоставим с эндоскопическими исследованиями.
По данным японских исследователей чувствительность
рентгенологического метода составляет 80%, эндоско-
пии – 86%, а специфичность соответственно 99,5% и
97%. Рентгенологический метод исследования нередко
единственный метод исследования позволяющий диагно-
стировать диффузный рак желудка в начальных стадиях.
Цель исследования – изучить возможности спиральной
компьютерной томографии в диагностике рака желудка.
Компьютерно-томографическое исследование проведено
14 пациентам с раком желудка в возрасте от 44 до 72
лет. Компьютерная томография, в дополнение к рутин-
ным рентгенологическим исследованиям, позволяет полу-
чить более полную информация о глубине инвазии опухоли
в пределах органа, степени распространения на смежные
органы, оценить состояние паренхиматозных органов,
регионарных и забрюшинных лимфоузлов. Двухэтапное
компьютерно-томографическое исследование позволило
более детально изучить толщину стенок желудка, выяв-
ля изменения от 7 мм, выявить прорастание окружаю-
щих органов и структур, метастатическое поражение
печени, а также определить поражение регионарных
лимфатических узлов в перигастральной области и за-
брюшинном пространстве. Показана необходимость
включения в алгоритм исследования рака желудка
спиральной компьютерной томографии в комплексе с
рентгенологическим и эндоскопическим методами ис-
следования.

among all malignant new growths. Existing methods of
research in most cases do not allow to diagnose initial displays
of a cancer of a stomach, therefore improvement of methods of
diagnostics is one of the major directions of clinical oncology.
To 60-90 % make spread forms of a cancer of a stomach. The
radiological method of research on sensitivity and specificity

is comparable with endoscopy researches. According to the Japanese researchers sensitivity of a radiological method makes 80 %, endoscopy – 86 %, and specificity accordingly 99,5 % and 97 %.

A radiological method of research quite often unique method of research allowing to diagnose diffused stomach cancer in initial stages. Research objective was to study possibilities of a spiral computer tomography in diagnostics of gastric cancer. CT research was spent to 14 patients at the age from 44 till 72 years with gastric cancer. The computer tomography, in addition to routine radiological researches, allows to receive fuller the information on depth

tumor, distribution degrees on adjacent bodies, to estimate a metastatic disease of the liver, regional and retroperitoneal lymph nodes. Two-step research is CT has allowed to study in more details a thickness of walls of a stomach, revealing changes from 7 mm, to reveal germination of surrounding bodies and structures, metastatic defeat of a liver, and also to define defeat regional lymph nodes in paragastral areas and retroperitoneal space. Necessity of inclusion for algorithm of research of a cancer of a stomach of a spiral computer tomography in a complex with radiological and endoscopy research methods is shown.

Актуальность

Рак желудка (РЖ) по показателям заболеваемости в странах Западной Европы и США занимает второе место среди злокачественных новообразований [1]. В Республике Казахстан рак желудка в структуре онкопатологии находится на 4 месте (2006г – 10,1%) [2].

На современном этапе клинической онкологии одним из важнейших направлений является пути выявления опухолей желудка и усовершенствование методов диагностики. Выявление РЖ на начальных этапах развития затруднено для всех существующих методов исследования [3,4]. Ведущими методами диагностики РЖ остаются рентгенологическое исследование и эндоскопия. Исследования S. Takasu с соавт. Показали, что чувствительность рентгенологического метода составляет 80%, эндоскопии – 86%, а специфичность соответственно 99,5% и 97% [5].

Начиная с 60-х гг., отмечается увеличение частоты развития диффузных форм РЖ, которые, по данным ряда авторов, составляют 60-90% [4]. Существенное значение в выявлении диффузного РЖ на всех этапах его развития, в том числе и при начальных проявлениях, приобретают методы лучевой диагностики и, прежде всего, рентгенологический с возможностью изучения контуров желудка и толщины его стенки. Нередко рентгенологический метод исследования – единственная возможность диагностировать диффузный рак желудка в его начальной стадии [4]. Но недостатком рутинного рентгенологического метода исследования желудка является невозможность получения точной информации о глубине инвазии опухолью стенки желудка. Для выявления вышеуказанных изменений в последние годы успешно применяется компьютерная томография желудка [6].

Цель исследования

- изучить возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике рака желудка.

Материалы и методы

Исследование выполнено 14 больным раком желудка в возрасте от 44 до 72 лет на спиральном компьютерном томографе «Aura» (Philips) компьютерно-томографическое исследование желудка проводили в два этапа. I этап включал в себя исследование желудка натощак, без заполнения его контрастом, в положении больного на спине. При этом оценивались анатомо-томографические взаимоотношения желудка со смежными органами, структура паренхиматозных органов, состояние регионарных и забрюшинных лимфатических узлов. II этап включал исследование желудка в условиях заполнения контрастом в горизонтальном

положении на спине – для более детальной визуализации стенок последнего. При необходимости использовалось полипозиционное исследование больного.

Результаты исследования

На КТ-срезах патологические изменения при раке желудка у 14 больных проявлялись утолщением стенки желудка от 0,7 до 38 мм. Опухолевая инфильтрация на выглядела в виде утолщения и неровности контуров, толщина стенки при этом колебалась от 7 мм до 21 мм у 6 (42,9%) больных, при распространенных процессах она визуализировалась до 38 мм у 8 (57,1%) больных. При подозрении на прорастание в смежные органы и структуры у 2 (14,3%) пациентов исчезала граница неравномерно утолщенной стенкой желудка и прилежащим органом – отмечалось слияние тени опухоли и смежного органа. Метастатическое поражение печени выявлено у 1 (7,1%) больного. Увеличенные перигастральные парааортальные лимфатические узлы до 20 мм определялись в 3 (21,4%) случаях, более 20 мм в 4 (28,6%) случаях и в виде конгломерата лимфоузлов в 2 (14,3%) случаях

Выводы

Компьютерная томография желудка является информативным методом исследования для оценки распространенности процесса при раке желудка. На современном этапе развития гастроэнтероонкологии диагностика опухолей желудка не должна ограничиваться только эндоскопическим и классическим рентгенологическим методами исследования; необходимо включать в алгоритм исследования рентгеновскую компьютерную томографию желудка.

Список литературы

1. Л.М. Портной, И.А. Казанцева, О.В. Вятчин, Г.А. Сташук, Л.Е. Гаганов. Рак верхнего отдела желудка: современные проблемы его диагностики//Вестник рентгенологии и радиологии. – 2003. – т.46, №6. – С. 4-22
2. Ж.А. Арзыкулов, Г.Ж. Сейтказина, Состояние онкологической помощи населению Республики Казахстан в 2006г (статистические материалы). – Алматы. – 2007.
3. Л.М. Портной. Рак желудка. Лучевая диагностика. – М.; Медицина, 1999. – 294С
4. Л.М. Портной. Современная лучевая диагностика в гастроэнтерологии и гастроэнтероонкологии. – М. – Видар. – 2001 – 224С
5. П.В. Власов. Лучевая диагностика рака желудка. Критика укоренившихся заблуждений// Вопросы онкологии. – 2000. – т. 46. - №1. – С. 654-665
6. Л.М. Портной, В.О. Нефедова, Е.В. Чекунова, Л.Б. Денисова. КТ в проблеме диагностики рака желудка (по материалам обзора литературы)// Вестник рентгенологии и радиологии. – 2000. - №4. – С. 51-57